SCIENZE UMANE E DELLA SALUTE

MC ANNO 2026/2027

DETERMINANTI DELLA SALUTE

Sono fattori esterni che incide e influisce sul benessere/malessere dell'individuo, all'infuori della malattia in senso stretto

Nascita dei sistemi sanitari

Nella socità post-rivoluzionaria francese, si fa largo l'idea che la salute sia un bene pubblico e che debba essere lo stato a gestirla

Nella seconda metà del XIX secolo nascono quindi i primi **sistemi sanitari in Europa**

Cosa fa parte di un sistema sanitario:

- **Risorse umane**: medici, infermieri, amministrazioni, altri settori di cura
- **Strutture e servizi sanitari**: ospedali, cliniche, farmacie, assistenza domiciliare,...
- **Istituzioni finanziarie**: tasse, assicurazioni
- **Governo**: monisteroo dipartimento della salute, pianificazione
- **Governance**: modalità di applicazioni delle decisioni del Governo
- **Farmaci e infrastrutture**: medicinali, apparecchiature mediche, digitali, logistiche,...
- **Informazioni sanitarie**: morbilità e morbosità, cartelle chiliniche, statistiche, ricerca, ...
- **Cittadini**: i pazienti

Evoluzione dei sistemi sanitari

- Durante la seconda metà del XX secolo in motli stati europei: contesto di estrema fiducia nella scienza e nella biomedicina moderna
- Aumento esponenziale di strutture, servizi, tecnologie di diagnosi e terapie → data la fiducia dei pazienti, aumenta di molto l'offerta
- L'aumento dell'offerta provoca un aumento della domanda e una conseguente esplosioni di costi della salute

Salutogenesi

Salutogenesi: letteralmente "*costruzione della salute*" Fino agli anni 80, circa, si pensava che le politiche per la salute si dovessero occupare solo dell'erogazione dell'assistenza medico-sanitaria, cioè delle cure mediche pubbliche

Si sviluppano sensibilmente in quel decennio le politiche di prevenzione delle malattie e di promozione della salute Contesto internazionale: la **"Carta di Ottawa"**

Carta di Ottawa: per la promozione della salute (OMS, 1989)

- "La salute è un diritto fondamentale di ogni essere umano, essa non é un fine ma una risorsa per la vita quotidiana"
- "La promozione della salute è il processo che consente alle persone di aumentare il controllo sulla propria salute e migliorarla"
- Non sono leggi, bensì raccomandazioni
- L'obbiettivo è diminuire la domanda di cure
- In breve: ogni persona in meno che va dal medico, è una persona in più che sta bene

→ cambia paradigma: La salute non è solo **assenza di malattia**, ma come un **bene dinamico**, influnezato da fattori sociali, ambientali, economici, culturali e personali

- Il modello antropologico propone un *approcio olistico* secondo un benessere della persona coinvolto nella totalità esistemziale
- Nella salutogenesi la ricerca è orientata allo studio dei fattori della salute (e di riflesso della sua mancanza)

Mentre le cure mediche possono guarire, prolungare la sopravvivenza e migliorare la prognosi di alcune malattie gravi, per la salute delle popolazioni risultano molto più importanti quelle condizioni ambientali, sociali ed economiche che fanno ammalare le persone e che le portano alla necessità di richiedere cure mediche.

Determinanti della salute

Sono i fattori la cui presenza modifica in senso positivo o negativo lo stato di salute di una persona, popolazione o comunità

I fattori della salute:

- fattori genetici/costituzionali/biologici
- Condizioni socio-economiche
- Condizioni ambientali/lavorativi
- Stili di vita, abitudini
- Cultura, valori, credenze

STORIA DEL PENSIERO MEDICO E DEI LUOGHI DI CURA

Introduzione

La storia del pensiero medico intreccia filosofia, scienza e cultura: l'idea di cura si trasforma continuamente, da equilibrio cosmico a sapere sperimentale basato sull'evidenza

La storia della medicina europea non è lineare: per secoli convivono medicina teorica, pratiche empiriche, religione, chirurgia artigianale e assistenza caritativa

Anche "**ospedale**" cambia significato: prima luogo di accoglienza, solo tra XIX e XX secolo diventa centro di diagnosi, terapia, ricerca e formazione — di pari passo con l'idea che la salute sia una questione pubblica di cui lo Stato deve occuparsi (diritto alla salute)

Antichità: da Ippocrate alla medicina greca

- Prima: malattia = ira degli dèi, impurità, forze soprannaturali → i malati dormivano nei **templi di Asclepio** attendendo un sogno rivelatore
- V-IV sec. a.C.: **Ippocrate** e il *Corpus Hippocraticum* rompono con le spiegazioni magiche:
  - salute = equilibrio dei 4 umori, malattia = rottura dell'equilibrio
  - cause naturali: alimentazione, clima, ambiente, stile di vita
  - il medico **osserva** il malato, registra i sintomi, formula una prognosi
  - → modello **naturalistico e razionale**: il corpo obbedisce alle leggi della natura

- *Luoghi di cura*: niente ospedali pubblici → abitazioni, templi, scuole mediche, palestre; medicina individuale e privata (i poveri: guaritori e rimedi tradizionali)
- *Formazione*: niente università → scuole mediche (Coo, Cnido) e apprendistato presso un medico

Età ellenistica e Roma: anatomia, sanità pubblica e Galeno

- Alessandria d'Egitto: interesse per anatomia e fisiologia (dissezioni di cadaveri)
- Roma: **medicina militare e sanità pubblica** → *valetudinaria* (per soldati e schiavi), terme, acquedotti e fognature, assistenza a poveri/orfani/anziani
- **Galeno** di Pergamo (II sec. d.C.):
  - sistema medico su anatomia + fisiologia + umori + filosofia; medicina come "arte razionale" (corpo = macchina perfetta animata da uno "spirito vitale" tra cuore e cervello)
  - dissezioni umane vietate → studiò animali → errori anatomici rimasti "autorevoli" per secoli (dominò fino al Rinascimento)
  - il medico deve essere anche filosofo

Alto Medioevo: monasteri, carità e conservazione del sapere

- Caduta dell'Impero → il sapere medico antico si conserva nei monasteri (copiatura di testi, piante medicinali)
- Visione cristiana: malattia = prova spirituale o disordine morale; cure = preghiere, dieta, salassi, erbe
- La **medicina araba** (Avicenna, Averroè) rielabora Galeno e sistematizza il sapere

- *Luoghi di cura*: **xenodochi** (stranieri e pellegrini), monasteri e infermerie monastiche, ospizi, lebbrosari → obiettivo: accogliere e assistere, più che guarire
- *Formazione*: monasteri, apprendistato; inizia a svilupparsi **Salerno**

Basso Medioevo: Scuola Salernitana, ospedali cittadini e università

- XI-XIII secolo: ripresa urbana e commerciale
- **Scuola Medica Salernitana**: confluenza di tradizioni greche, latine, arabe, ebraiche e bizantine (Ippocrate e Galeno, dieta e igiene, farmaci, uroscopia, ostetricia, chirurgia)
    - **Costituzioni di Melfi (1231)**: per esercitare la medicina serve un esame pubblico → prima regolamentazione professionale
- *Ospedali cittadini* in moltiplicazione (confraternite, ordini religiosi, comuni, vescovi): assistenza più che terapia; strutture specializzate: **lebbrosari** (isolamento cronici), **lazzaretti** (contagiosi), ospizi, ospedali militari
- Nascono le **università** (Bologna, Padova, Montpellier, Parigi, ...): lezioni e commento dei testi autorevoli (Galeno e Avicenna dominanti)
    - a Bologna **Mondino de' Liuzzi** introduce nel primo '300 la dissezione pubblica di cadaveri
    - l'università forma medici teorici; la chirurgia resta ai pratici e ai barbieri-chirurghi

Rinascimento: anatomia, ospedale e critica di Galeno

- L'Umanesimo porta fiducia nell'osservazione diretta: si confronta ciò che Galeno scrisse con ciò che si vede nelle dissezioni → il sapere medico si laicizza

- **Vesalio**, *De humani corporis fabrica* (1543): critica gli errori galenici; il professore osserva e dimostra di persona sul cadavere
- Altri protagonisti: **Paré** (chirurgia e ferite), Colombo e Falloppio (anatomia), **Fracastoro** (malattie contagiose), **Harvey** (circolazione sanguigna, inizio '600)
- *Ospedali*: più grandi e organizzati (corsie, reparti), ma ancora caritativi: sovraffollamento, mortalità alta, scarsa igiene; il medico visita a casa, in corsia operano religiosi e assistenti

XVII secolo: rivoluzione scientifica e fisiologia

- Nuovo modo di studiare il corpo: osservazione, misurazione, esperimento, strumenti
- **Harvey** dimostra la circolazione del sangue; il **microscopio** rivela strutture invisibili
- *Ospedali*: ancora carità/militari; inizia la separazione dei malati per tipologia → l'ospedale diventa lentamente luogo di osservazione, ma le terapie restano salassi, purghe, dieta e chirurgia senza anestesia
- Accanto alle università nascono le **accademie scientifiche**; la ricerca innovativa spesso avviene fuori dalle facoltà

Illuminismo e XVIII secolo: nascita della medicina clinica e sociale

- Si affermano osservazione clinica e classificazione delle malattie, attenzione a condizioni ambientali e sociali: igiene urbana, studio di mortalità ed epidemie, medicina militare
- **Jenner** (fine secolo): vaccinazione contro il vaiolo → nasce la prevenzione delle infezioni
- Distinzione più netta tra medicina, chirurgia e farmacia

- *Ospedali generali* più grandi e riformati: reparti separati, registrazione dei casi, regole per gli infermieri → a fine secolo nasce l'**ospedale clinico**: i pazienti diventano oggetto di insegnamento e osservazione
- Università riformate: più anatomia, fisiologia e pratica al letto del malato

XIX secolo: l'ospedale moderno e la medicina scientifica

La grande svolta: addio alla teoria umorale → anatomia patologica, fisiologia sperimentale, chimica, microbiologia

Figure decisive:

- **Laennec** → auscultazione e stetoscopio
- **Morgagni** → collega i sintomi alle lesioni degli organi
- **Bernard** → fisiologia sperimentale
- **Virchow** → patologia cellulare
- **Semmelweis** → lavaggio delle mani
- **Pasteur e Koch** → teoria dei germi
- **Lister** → antisepsi chirurgica
- **Morton** → anestesia

Ospedali: da luogo caritativo a istituzione scientifica → diagnosi, trattamento, formazione, ricerca; sale operatorie, laboratori, radiologia (fine secolo), reparti specializzati. Anestesia → interventi lunghi; antisepsi/asepsi → crollo delle infezioni chirurgiche

Università (modello tedesco): lezioni + laboratorio + dissezione + clinica + ricerca + tirocinio ospedaliero. Lo Stato regola titoli ed esami → si crea l'alleanza Stato-medicina (dal 1895 i medici possono dichiarare l'inabilità lavorativa)

XX secolo: medicina tecnologica e sistemi sanitari

Progressi che cambiano radicalmente la sopravvivenza: radiografie, ECG, **insulina**, **antibiotici** (la penicillina abbatte la mortalità per infezioni), trasfusioni, vaccini, terapia intensiva, chirurgia cardiovascolare, trapianti, chemioterapia, ecografia/TAC, genetica

- Medicina sempre più specializzata e interdisciplinare
- *Ospedali* organizzati in reparti e servizi (medicina interna, chirurgia, pediatria, ostetricia, psichiatria, radiologia, pronto soccorso, riabilitazione, ...) e integrati in **sistemi sanitari pubblici o assicurativi**
- Dall'assistenza caritativa al **diritto sociale alla salute**: è lo Stato a occuparsi della salute dei cittadini
- *Università*: facoltà legate agli ospedali universitari; si impara con lezioni, laboratori, tirocini e ricerca; poi la specializzazione

XXI secolo: medicina basata sulle prove e personalizzata

Fondata su: metodo scientifico, medicina basata sulle evidenze (EBM), tecnologie digitali, genetica/genomica, prevenzione, epidemiologia, assistenza multidisciplinare, comunicazione col paziente

L'ospedale non è più l'unico luogo di cura: medicina territoriale, ambulatori, assistenza domiciliare, **telemedicina**, riabilitazione, hospice, salute mentale, prevenzione → l'ospedale concentra i casi complessi, la chirurgia avanzata, la diagnostica e la ricerca

Il medico contemporaneo è insieme scienziato, clinico, comunicatore e membro di un'équipe

Situazione attuale e prospettive

- Il "buon governo" (diritto alla salute + sistemi sanitari pubblici) e i progressi scientifici hanno creato una fiducia incondizionata nella medicina → "contratto" Stato-società-medicina basato sull'onnipotenza della medicina tecnologica
- Le sfide postmoderne: ritorno alla dimensione umana della cura → il **modello bio-psico-sociale** (pluricausale, olistico) riapre il tema della relazione curante-paziente e degli aspetti culturali di salute e malattia
- Crescono i modelli vitalistici (omeopatia, medicine alternative) e i dubbi bioetici sulla medicina molecolare
- Alcuni principi di Ippocrate tornano attuali dopo 2000+ anni: la sfida è conciliare valori umanistici e progresso scientifico, mettendo al centro il malato

L'etica medica di Ippocrate

Ippocrate di Cos (460 - ca. 370 a.C.): fondatore della medicina occidentale e della tradizione dell'etica medica

- **Primum non nocere**: "tendere nelle malattie a due scopi: giovare o non essere di danno"; se non può essere utile, il medico non deve aggravare lo stato del malato
- **Rispetto della vita umana** (dal *Giuramento*):
  - divieto di somministrare farmaci mortali ("non darò a nessuno alcun farmaco mortale, neppure se richiestone") → all'epoca *pharmakon* = medicamento *e* veleno, e il commercio era privo di regole
  - divieto di procurare l'aborto (col pessario)
- **Paternalismo medico**: competenza del medico vs ignoranza del paziente → rapporto asimmetrico; il malato è arrendevole solo quando ha male o paura. Il Giuramento vieta

però di approfittarne (divieto di atti di libidine sui pazienti, "liberi o schiavi")

- **Segreto professionale**: ciò che il medico vede e ode, "lo tacerò ritenendolo alla stregua di un sacro segreto"

Confronto con la situazione attuale

Riferimenti: *Codice deontologico dei medici svizzeri* (FMH, 1997) e *Legge sanitaria del Canton Ticino* (1989)

- **Scopo della medicina** (art. 2 Codice): proteggere la vita, promuovere la salute, guarire, alleviare le sofferenze e assistere i moribondi — nel rispetto di dignità, personalità, volontà e diritti del paziente (art. 4)
- **Convinzioni morali del medico**: può rifiutare atti incompatibili con la sua coscienza (art. 3) → **obiezione di coscienza** (art. 18 Legge sanitaria TI): non può essere discriminato, ma non può compromettere le prestazioni della struttura, e in caso di urgenza deve comunque collaborare
- **Consenso del paziente** → il grande cambiamento rispetto a Ippocrate: superato il paternalismo, si affermano i **diritti del paziente**:
  - diritto a essere informato in modo chiaro e accessibile (diagnosi, piano di cura, rischi, alternative)
  - **consenso cosciente** necessario per qualsiasi prestazione (art. 7); presunto solo se non invasiva/senza rischi rilevanti, o in pericolo di morte imminente
  - resta il divieto ippocratico di approfittare della dipendenza del paziente (emozionale, sessuale o materiale)
- **Segreto professionale**: immutato, anzi rafforzato → silenzio su tutto ciò che si apprende nell'esercizio della professione; protegge la sfera privata del paziente

Tabella riassuntiva

Epoca	Idee mediche	Luoghi di cura
Antichità greca	da medicina religiosa a razionale (Ippocrate)	templi di Asclepio, case, palestre
Ellenismo e Roma	anatomia, umori, sistemazione galenica	valetudinaria militari, terme
Alto Medioevo	conservazione nei monasteri, componente religiosa	xenodochi, monasteri, ospizi
Basso Medioevo	recupero di Ippocrate/Galeno, medicina araba, prime dissezioni	ospedali cittadini, lebbrosari, lazzaretti
Rinascimento	anatomia diretta, critica di Galeno (Vesalio)	ospedali più organizzati ma caritativi
XVII secolo	rivoluzione scientifica, circolazione, metodo sperimentale	ospedali di carità e militari
Illuminismo	clinica, classificazione, vaccinazione, medicina sociale	ospedali generali, nasce l'ospedale clinico
XIX secolo	anatomia patologica, germi, anestesia, antisepsi	ospedale moderno: sale operatorie, laboratori

Epoca	Idee mediche	Luoghi di cura
XX secolo	antibiotici, radiologia, specializzazione	ospedali tecnologici, sistemi sanitari pubblici
XXI secolo	EBM, genomica, personalizzata, digitale	ospedale + territorio, telemedicina